

## **Transcrição do podcast de revisão do Módulo: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)**

**Vivian:** Olá, hoje nossa análise vai fundo num tema complexo: o sistema prisional brasileiro. Vamos olhar desde a história das punições até as políticas de hoje que buscam garantir a saúde das pessoas privadas de liberdade.

**Caio:** Exato. É um tema denso, sabe? Reflete desafios sociais bem profundos. Vamos tentar entender como o Brasil lida com o encarceramento em massa e, claro, a estrutura para oferecer saúde nesse contexto.

**Vivian:** Certo. Vamos começar por aí então. Como foi essa evolução, da vingança ao encarceramento moderno?

**Caio:** Bom, a trajetória é longa. Mas a gente percebe uma mudança bem clara. Saímos daquela ideia de vingança privada, tipo a Lei de Talião, sabe? O "olho por olho"...

**Vivian:** Uh-hum.

**Caio:** ...para uma coisa mais centralizada no Estado. O Estado assume a responsabilidade de punir. E aí a privação de liberdade — o encarceramento — se tornou a principal forma de pena.

**Vivian:** E em algum momento isso explodiu, essa questão do encarceramento?

**Caio:** Sim, totalmente. A partir dos anos 70, mais ou menos, houve um boom global. Tem vários fatores aí: a crise do Estado de bem-estar social, por exemplo, mas principalmente as políticas de "guerra às drogas".

**Vivian:** Ah, isso teve um impacto grande no Brasil, imagino.

**Caio:** Enorme. A Lei Antidrogas de 2006 aqui foi um marco nesse sentido, intensificou demais o aprisionamento. Soma isso com a sensação de insegurança, muitas vezes turbinada pela mídia, e pronto: o Brasil virou um dos países com maior população prisional.

**Vivian:** Impressionante. E hoje, como está a estrutura legal disso? Em 2025, o que rege a execução penal?

**Caio:** Basicamente a Lei de Execução Penal, a LEP, que é de 1984, e o Código Penal. Aí temos as penas que privam a liberdade mesmo — reclusão e detenção, cumpridas na prisão — mas também tem as restritivas de direitos, tipo serviço comunitário e a multa.

**Vivian:** E tem a progressão de regimes, certo? Fechado, semiaberto...

**Caio:** Isso. A ideia é que a pessoa possa progredir. Começa no fechado, depois pode ir para o semiaberto, onde já pode sair para trabalhar ou estudar, e por fim o aberto, com mais flexibilidade. Pelo menos na teoria.

**Vivian:** E quem são essas pessoas no sistema? Os números dão uma dimensão, imagino?

**Caio:** Os números são chocantes. Dados de 2024 apontam mais de 900 mil pessoas sob custódia do Estado. Isso incluindo quem está em prisão domiciliar. É muita gente.

**Vivian:** E o perfil?

**Caio:** O perfil é muito, muito marcado. A esmagadora maioria, 94%, são homens. A faixa etária predominante fica ali entre 35 e 45 anos. E a questão racial e social é gritante: maioria parda ou preta.

**Vivian:** E a escolaridade também, você mencionou?

**Caio:** Pois é, baixíssima. Muitos não terminaram nem o ensino fundamental. E tudo isso num cenário de superlotação brutal. Falta vaga para quase 200 mil pessoas só no regime fechado. É um barril de pólvora.

**Vivian:** E nesse cenário tão difícil, como fica o direito à saúde? A liberdade está restrita, mas outros direitos permanecem, certo?

**Caio:** Perfeito. Esse é um ponto crucial. A própria LEP, a Lei de Execução Penal, garante a assistência à saúde. É um dever do Estado. Só que por muito tempo ficou mais na lei do que na prática, entende?

**Vivian:** Entendo. E quando isso começou a mudar de verdade?

**Caio:** O primeiro passo importante foi em 2003, com o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional, o PNSSP. Ele foi pioneiro porque começou a alinhar a saúde prisional com os princípios do SUS. Tirou um pouco aquela visão puramente de segurança.

**Vivian:** Ah, interessante. Deixou de ser só um problema da segurança pública para ser também da saúde.

**Caio:** Exatamente. Mas o grande avanço veio depois, em 2014, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. É um nome longo, a gente chama pela sigla PNAISP, pronunciando "Penaisp".

**Vivian:** PNAISP. Ok. E qual é a essência dela? O que a PNAISP busca?

**Caio:** O objetivo principal é bem claro: garantir o acesso ao cuidado integral no SUS para todas as pessoas privadas de liberdade. Ela se baseia nos princípios do SUS: integralidade, equidade, humanização e também participação social. A ideia é que a pessoa receba o cuidado que precisa onde precisa, seja dentro ou fora da prisão.

**Vivian:** E na prática, como isso acontece? Quem faz isso no dia a dia?

**Caio:** A chave para operacionalizar a PNAISP são as Equipes de Atenção Primária Prisional. A sigla é EAPP, e a gente fala "E-A-P-P".

**Vivian:** As EAPPs.

**Caio:** Isso. Para ter essas equipes, os estados e municípios precisam primeiro aderir formalmente à política, à PNAISP.

**Vivian:** E como essas equipes EAPPs são formadas? E o financiamento, como funciona?

**Caio:** Depois que o estado ou município adere, o gestor local solicita o credenciamento das equipes. Isso é feito por um sistema online, o e-Gestor APS. Existem tipos diferentes de equipe, sabe? Tem a essencial, a ampliada, a complementar psicossocial...

**Vivian:** Depende do tamanho da unidade prisional, imagino?

**Caio:** Exato. E da necessidade. As cargas horárias também variam: 6, 20, 30 horas semanais. A composição mínima inclui médico, enfermeiro, dentista, mas pode ter psicólogo, assistente social, farmacêutico... depende da modalidade.

**Vivian:** E o dinheiro para isso? Vem de onde?

**Caio:** O financiamento principal é federal, repassado fundo a fundo. Mas para receber, tem um passo crucial: a equipe tem que estar cadastrada direitinho no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES. A gente pronuncia "Quines". Sem esse cadastro no "Quines", nada de verba federal.

**Vivian:** Entendi. O "Quines" é a chave para o fluxo financeiro. E o que essas equipes EAPPs fazem lá dentro no dia a dia? Quais são as responsabilidades?

**Caio:** Elas são a porta de entrada para a saúde ali na unidade. O trabalho delas envolve desde promoção e prevenção até diagnóstico, tratamento e reabilitação. É atenção primária mesmo, só que adaptada à realidade prisional.

**Vivian:** Um trabalho bem amplo.

**Caio:** Muito amplo. E tem que garantir um atendimento humanizado, coordenar o cuidado quando a pessoa precisa ir para um hospital ou outro serviço fora da unidade — o que a gente chama de fluxo na Rede de Atenção à Saúde, a RAS — e fazer educação em saúde também.

**Vivian:** E se a equipe não funcionar direito? Se faltar profissional, por exemplo?

**Caio:** Aí tem problema. O financiamento pode ser suspenso. Se a equipe estiver incompleta por muito tempo ou se o município não enviar as informações sobre os atendimentos para o Ministério da Saúde através do SISAB, a verba pode ser cortada. É uma forma de monitorar.

**Vivian:** Então para resumir: temos uma política nacional, a PNAISP, bem estruturada no papel, com equipes específicas, as EAPPs, e regras claras de financiamento, tudo para tentar garantir o direito à saúde dessas pessoas.

**Caio:** Exatamente isso. A PNAISP é, sem dúvida, um avanço civilizatório importante. Ela reconhece que saúde é um direito de todos, não importa a condição. Agora, os desafios para implementar isso de verdade são gigantescos.

**Vivian:** Imagino. A superlotação, as condições das prisões...

**Caio:** Tudo isso. A própria estrutura, o estigma... Mas ter a política é o primeiro passo fundamental. O desafio é fazer ela sair completamente do papel e chegar a todos que precisam.

**Vivian:** Fica então uma reflexão, talvez? Se a gente olha para esse perfil da população privada de liberdade que é majoritariamente pobre, negra, com baixa escolaridade, até que ponto a luta para fazer a PNAISP funcionar lá dentro não está ligada a uma necessidade ainda maior, que é de enfrentar as desigualdades aqui fora, que acabam alimentando o próprio encarceramento?

**Caio:** Sem dúvida.